

Гіпоглікемія

На зупинці громадського транспорту чоловіку 58 років раптово стало зле — він відчув запаморочення, пітливість, слабкість, тремтіння в руках. Перехожі викликали екстрену медичну допомогу. Ви — фельдшер бригади ЕМД, прибули на місце події. Відомо, що пацієнт страждає на цукровий діабет 2 типу, постійно приймає глібенкламід.

Скарги: на загальну слабкість, запаморочення, тремор рук.

Анамнез захворювання: Пацієнт близько 58 років страждає на цукровий діабет 2 типу.

Анамнез життя: Туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ-інфекцію заперечує. Хворів ГРВІ. Операцій та травм не було. Алергічних реакцій немає. Спадковість: необтяжена.

Об'єктивно: стан середньої тяжкості, у свідомості. Сидить на лавочці. Шкіра блідо-рожева, волога. Ріст 175см, вага 73 кг. Периферичний набряків немає. Експерсія грудної клітки симетрична. ЧДР 20/хв, Аускультативно над легенями жорстке дихання, проводиться у всі відділи. Межі відносної серцевої тупості не розширені. Тони серця ясні ритмічні, патологічних шумів немає. ЧСС=PS=90/хв., АТ - 110/60 мм рт.ст., Живіт м'який, доступний пальпації у всіх відділах, безболісний, приймає участь у акті дихання. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Симптом Щьоткіна-Блюмберга негативний. Аускультативно - перистальника активна. Ділянка попереку без патології. Нирки не пальпуються. Симптом Пастернацького негативний з обох боків. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.

Додатково:

Клінічний аналіз крові (додається)

Біохімічний аналіз крові (додається)

Провести аналіз рівня глюкози в крові, інтерпретувати отримані під час додаткового обстеження пацієнта дані, встановити клінічний діагноз та визначити подальшу тактику лікування.

Аналіз рівня глюкози в крові-

Клінічний аналіз крові

Показник	Результат	Референтні значення
Гемоглобін, г/л	110	130–160 (чол.), 120–140 (жін.)
Еритроцити, $\times 10^{12}/л$	3,6	4,0–5,0 (чол.), 3,9–4,7 (жін.)
Кольоровий показник	0,85	0,85–1,15
Тромбоцити, $\times 10^9/л$	200	180–320
Лейкоцити, $\times 10^9/л$	7,8	4,0–9,0
Лімфоцити, %	28	19–37
Еозинофіли, %	2	0,5–5,0

Палочкоядерні нейтрофіли, %	4	0–5,0
Сегментоядерні нейтрофіли, %	60	47–72
Моноцити, %	6	3–11
ШОЕ, мм/год	10	1–10 (чол.), 2–15 (жін.)

Біохімічний аналіз крові – гіпоглікемія

Показник	Результат	Референтні значення
Загальний білок, г/л	60,0	60–80
Глюкоза, ммоль/л	2,6	3,3–5,5
АлАТ, мкмоль/л·год	0,42	0,1–0,68
АсАТ, мкмоль/л·год	0,40	0,1–0,45
Холестерин, ммоль/л	5,1	3,9–5,2
Білірубін загальний, мкмоль/л	17,2	8,5–20,5
Білірубін прямий, мкмоль/л	4,2	1,05–5,4
Білірубін непрямий, мкмоль/л	13,0	6,5–15,4
Креатинін, мкмоль/л	91	44–97
Сечовина, ммоль/л	5,5	2,5–6,4

11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Привітання з пацієнтом, встановлення контакту.	Сказати <i>Доброго дня. Я лікар центру екстреної медичної допомоги (Ім'я).</i>
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного дослідження	Сказати <i>Ви даєте свою згоду на проведення обстеження та медичних маніпуляцій (Будемо вважати що згода отримана)</i>

1.3	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавиці.	Сказати <i>Будемо вважати, що руки оброблені</i>
2.3бір скарг та анамнезу		
2.1	Анамнез хвороби	Сказати «Що з Вами трапилось» <i>Очікуваний відповідь « раптово стало зле —коли відчув запаморочення, пітливість, слабкість, тремтіння в руках, страждає на цукровий діабет 2 типу, приймаю метформін 1000 мг на добу.Після погіршення стану було викликано бригаду ЕНМ»</i>
2.2	Скарги постраждалого	Сказати: «Які у вас скарги?» <i>Очікуваний відповідь:слабкість, запаморочення</i>
2.3	Анамнез життя	Сказати: «Які захворювання ви перенесли?» <i>Очікувана відповідь: «ГРВЗ, дитячі інфекції, Туберкульоз, гепатити, сифіліс, ВІЧ-інфекцію заперечує. Хворів ГРВІ. Операцій та травм не було. Цукровий діабет 2 типу останні 10 років»</i>
2.4	Алергійний анамнез	Сказати «Чи були у Вас алергійні прояви раніше і на що?» <i>Очікувана відповідь: «Ні, алергій не було»</i>
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Загальний стан.	<i>Сказати:стан середньої тяжкості, у свідомості. Сидить на лавочці. Шкіра блідо-рожева, волога. Ріст 175см, вага 73 кг. Периферичний набряків немає. Екскурсія грудної клітки симетрична. ЧДР 20/хв, Аускультативно над легеньми жорстке дихання, проводиться у всі відділи. Межі відносної серцевої тупості не розширені. Тони серця ясні ритмічні, патологічних шумів немає. ЧСС=PS=100/хв., АТ - 90/60 мм рт.ст., Живіт м'який, доступний пальпації у всіх відділах, безболісний, приймає участь у акті дихання. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Симптом Щоткіна-Блюмберга негативний. Аускультативно - перистальника активна. Ділянка попереку без патології. Нирки не пальпуються. Симптом Пастернацького негативний з</i>

		<i>обох боків. Випорожнення та сечовипускання без особливостей.</i>
3.2	Прогресування хвороби	<i>Сказати: «Під час проведення огляду постраждалий став млявим»</i>
4.Діагностика		
4.1	Встановити клінічний діагноз	<i>Сказати :«Гіпоглікемічний стан на фоні цукрового діабету 2 типу»</i>
5.Визначення тактики ведення та лікування. Алгоритм надання екстреної медичної допомоги		
5.1	Перший крок: Рекомендується перша лінія лікування - При збереженій свідомості або при одночасному жувальному і кашльовому рефlekсах можливе швидке введення через рот вуглеводів, що легко засвоюються.	<i>Сказати : «Допомагаємо пацієнту випити солодкий напій »</i>
5.2	Другий крок:При тяжкій гіпоглікемії зі втратою свідомості з або без судом (зокрема, з блюванням) встановити внутрішньовенний катетер та ввести глюкагон.У разі відсутності глюкагону, при порушенні свідомості показано в/в введення розчину 40% глюкози 0,2 мл/кг до виходу з коми, припинення судом.	<i>Виконати: «Після обробки шкіри розчином антисептика встановлюю периферичний катетер, починаю введення розчину глюкози»</i>
5.3	Третій крок: При збереженні порушення свідомості та судамах — повторити введення 40% глюкози до 5 мл/кг. Якщо порушення свідомості та судами зберігаються, продовжувати крапельне введення 5% глюкози під час транспортування пацієнта до стаціонару.	<i>Сказати: «Проводимо введення 40% глюкози до 5 мл/кг. Якщо порушення свідомості та судами зберігаються, продовжувати крапельне введення 5% глюкози під час транспортування пацієнта до стаціонару»</i>
5.4	Четвертий крок: Пацієнти з гіпоглікемічним станом потребують постійного моніторингу вітальних функцій та переведення до відділення інтенсивної терапії.	<i>Сказати: «Постраждалий бригадою екстреної невідкладної допомоги доставляється до профільного закладу для подальшого нагляду та лікування».</i>
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	<i>Сказати :- Спокійний режим, уникнення фізичних навантажень, виконання рекомендацій лікарів в подальшому обстежені та лікуванні.</i>
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		

7	Інформування пацієнтки про можливі ризики та етичні аспекти	<i>Сказати-</i> Ви повинні знати про можливі ризики, які можуть виникнути за умов порушення прийому препаратів(недотримання призначеної дози), і в подальшому при виникненні таких ситуацій не зволікати а одразу викликати швидку. Звернутися до свого сімейного лікаря, ендокринолога для корекції терапевтичної дози гіпоглікемічних засобів.
---	---	--